附件1

全国教育科学规划项目
基础教育改革创新实践案例申报信息表

一、基本信息	
基本描述信息	
案例名称	身心一体、整全健康：县域初中健康学校课程重构实践
关键词（3–5个）	健康第一；整全健康；课程重构；健康画像；家校社医协同
案例类别	□ 区域层面　　☑ 学校层面
案例方向	坚持立德树人为本（落实“健康第一”教育理念的育人实践）
所属项目	项目负责人：丁锦宏；项目名称：青少年情感教育的内涵、体系和范式研究；项目编号：BEA230076；项目类别：一般项目
展示方式	若被选中参与论坛展示，请选择展示方式（可多选）： ☑ 海报设计　　□ 案例视频　　□ 闪电演讲
二、案例简介	
案例概要	如皋市实验初中面对初中生久坐少动、近视与超重肥胖增多、心理问题隐蔽、社会适应能力不足，以及健康教育分散在体育、德育、后勤等条块中的问题，以“身心一体、整全健康”为统领，将健康从活动安排重构为课程体系。学校设置健康身体、健康心理、健康社会适应三类课程：前者聚焦体能、视力与体态，中者建立预防、发展、干预三级方案，后者贯通友好相处、集体融入和志愿服务。学校以体测、视力、脊柱、心理筛查和饮食运动数据形成“健康画像”，以日常课程、全员比赛、导师关爱和志愿实践推动行为改变，以“三元五维”评价和“绿色质量”考核改进实施，形成“监测诊断—课程供给—日常行动—评价改进”闭环。2023年273名超重肥胖学生纳入管理，一学期平均减重12.8斤；男生引体向上一年平均增加1.8个，每日有效运动增加40分钟。案例的可迁移点在于把监测、课程、日常行为和评价连成可追踪链条，并让家长、医疗与社区资源共同支持每一个学生，而不是只组织几项健康活动。

解决的主要问题、解决问题的过程与方法	原实践把健康视为体育课、心理辅导和食堂管理的专项任务：体育教师盯体测，心理教师处理个案，班主任抓成绩，家长在出现明显问题后才被通知；学生知道“要健康”，却缺少持续练习、自主管理和及时求助的机会。学校将273名超重肥胖学生纳入减脂餐与健康监测，但统一加练或一次讲座既难持续，也容易把健康变成对少数学生的矫正。 项目关于情感教育主体生成、关系支持和行动实践的认识，为学校提供了关键判断：健康不能只靠外部要求，要在安全关系、真实任务和持续反馈中形成自我管理。学校据此形成“一体三维四环”实践模式：以“身心一体、整全健康”为一体，以健康身体、健康心理、健康社会适应为三维，以监测诊断、课程供给、日常行动、评价改进为四环；教师、家长、医疗与社区资源构成支持系统。  图1　“一体三维四环”健康学校课程育人模式 第一，从减脂餐起步验证需求。学校为超重肥胖学生设置低油、低糖减脂窗口，邀请营养专家培训学生与家长，发放挑战卡、配置体脂秤，并建立选餐与体重记录。一周后窗口使用明显增加，一学期后纳入管理的273名学生平均减重12.8斤。学校由此把单点服务扩展为营养点餐、运动处方和体态干预。 第二，把有效做法转为三类课程。健康身体课程实行每天一节体育课的“3+2”结构，开展“月月有比赛”、课桌操、正脊操、眼球操和课间微运动，统筹课间、午间和大课间，每日校内有效运动增加40分钟；建立视力电子档案、脊柱档案和教室光环境检测。健康心理课程落实每天润心广播、心理晴雨表、每周微课、每月沙龙、每学期普查和全员导师制；对重点学生实行ABC分级关爱，开设“未来可期”课程。健康社会适应课程从友好相处、我爱集体走向志愿服务，每生每学期完成不少于8次、10小时服务。 第三，用数据与协商持续调整。学校将饮食、运动、体测、视力、脊柱和心理数据汇入“健康画像”，既生成个体建议，也用于课程改进；同时设置隐私边界，不公开学生健康排名。遇到教师“健康不是我的责任”的抵触，学校用脑科学、运动学培训和试点班级观察形成共识；遇到活动零散，则以课程表、责任人和固定时段固化。 第四，把评价变成保障。“三元五维”评价把学生自评、同伴互评、师长评价与德智体美劳中的健康指标结合；“绿色质量”考核把课业负担、课堂生态、近视变化等纳入教师评价，并以课时公开、常态督查防止健康时间被挤占。这一模式分阶段生成：先以减脂餐试点发现真实需求，再把有效做法课程化；先由单部门执行，再建立跨部门协商；先记录单项指标，再形成健康画像和绿色质量考核。

案例创新点	一是从“专项工作”转向“课程结构”。案例没有继续叠加活动，而是把健康身体、健康心理、健康社会适应三条目标转化为可排入课表、可连续实施、可相互衔接的课程群。减脂餐、心理晴雨表和志愿服务不再是孤立项目，而是分别进入体态管理、预防课程和社会适应课程，形成稳定的课程载体。 二是从“统一要求”转向“健康画像”。学校把体测、视力、脊柱、饮食、运动和心理筛查数据用于个体建议和课程诊断，强调“看趋势、给支持”，不以公开排名制造压力；教师据此调整运动处方、饮食选择和关爱方式，使数据服务关系而非替代关系。这一转变把“一个都不能少”落实为个体差异被看见、支持被调整。 三是从“单部门负责”转向“全校治理”。健康指标进入班级、教师和学校评价，体育、心理、德育、总务、医务与家庭、社区、医院形成协同；“近视率上升过快不得评优”等措施使健康从倡导变成有资源、有时段、有责任人的刚性安排。学校还通过家长陪餐、膳食委员会、健康筛查和教师培训，把健康嵌入学校日常制度而非迎检材料。
案例实践及推广情况 （列出3个以内推广应用单位及使用效果）	学校已将健康第一纳入章程、课程表和日常治理，形成面向全体、兼顾重点学生的实施格局。连续监测显示：纳入管理的273名超重肥胖学生一学期平均减重12.8斤；男生引体向上一年平均由0.8个提高到接近2个；每日校内有效运动增加40分钟；学校建立覆盖全体学生的视力与脊柱健康档案，并通过“健康画像”持续追踪。心理方面形成“预防—发展—干预”三级课程，学校材料将“未来可期班”学业困难与心理困扰学生的转化率记为90%；该数据在正式引用时应明确样本、分子、分母、随访时点和“转化”的操作定义。社会适应方面，每生每学期完成不少于8次、10小时志愿服务。 实践已从单项举措走向学校文化。体育、心理、德育、总务和医务共同承担健康责任；家长通过膳食委员会、陪餐和亲子运动参与；学校与公安、民政、卫生等部门开展心理关爱和健康筛查。学生层面由“被检查”逐步转向“会选择、能坚持、愿求助”，教师层面由完成体测转向依据数据调整课程与支持。 实践得到专业平台与媒体关注。学校党总支书记裴友军撰写的《健康学校建设的问题检视与实践探索》发表于《江苏教育研究》2026年第8期第18—22页；校长以“一个都不能少：教育最动人的模样”在2026年7月省级教育交流中报告健康学校建设；央广网报道学校减脂专窗，南通日报报道学校减脂餐和健康学校建设做法。学校还通过专题展示、跟岗交流等方式分享“健康画像”、心理关爱和课程建设经验。 当前推广以本校常态实施、集团与区域教研、专题交流为主；尚无经签字盖章的外部单位正式采用证明，因此不虚构校外应用单位及其效果。外校复制时应至少具备六项条件：健康第一进入学校章程和课表；体育、心理、德育、后勤有共同负责人；具备可持续的数据采集与隐私保护；建立学生、教师、学校三层评价；有家校社医协同机制；不以短期减重或分数波动替代健康改进。 完整原件包包括273名学生减重监测、引体向上记录、课程表、心理关爱与志愿服务过程材料、媒体报道、论文和专题视频。

佐证材料	远程证据网站：https://nantongdjh1966-sudo.github.io/rugao-health-first-case/ 。网站含“一体三维四环”模式图、关键数据、课程体系、媒体与专业成果、材料目录和申报表阅读版。完整原件包存放于百度网盘，链接与提取码随申报材料定向提供。公开网页不使用学生正脸照片。

三、案例曾获奖励情况（非必填，限填3项）

时间	案例名称	奖项名称	获奖等级(省部级及以上)	颁奖部门

四、单位意见

推荐意见	我单位是该案例的设计者和实施者，拥有完全的自主知识产权，并愿意参与全国教育科学规划项目－基础教育改革创新案例推荐展示活动和案例结集出版活动。 项目负责人签字: （非部属高校）盖章处: 年 月 日
	部属单位科研管理部门或省级教育规划办推荐盖章 （盖章处） 年 月 日